EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94875
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-15 10:40:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARGARITA DEL CARMEN MU►OZ CORTES			RUN	: 6.581.104-9
F.Nac	: 01-03-1947	Edad	: 77 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: ROBLE 034			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 422412293		
Fecha Ingreso	: 2024-09-21	Fecha Egreso	: 2024-10-15 10:40:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

IPPB: Celulitis De MII tratada
Hematoma En M. Iliacos Bilaterales Y Retroperitoneal
-Obs Meralgia Parestésica?
FA CON RVR S/TACO
Discopatia Lumbar Degenerativa
Cambios degenerativos de la art femoropatelar pared del compartimiento medial

Antec: Insuficiencia Vascular Periférica Crónica, TAVI 2021, HTA, EPOC GOLD D, Trombo En Orejuela Izq???, Obesidad Mórbida, Coxartrosis.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L03-CELULITIS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa con cuadro de Celulitis en MII extensa desde el hallux hasta la región inguinal, se inicia ABT con cloxa y clinda con buena respuesta clinica al 6to dia de tratamiento empieza con dolor en cadera que limita su deambulacion, se realiza TAC de pelvis+ columna lumbar y se solicita evaluacion por TMT ante sospecha de coxartrosis es evaluada y se mantienen indicaciones, luego se rescata informe de scanner con hallazgo de hematoma bilateral de ambos M. psoas iliacos mayor a izquierda, se suspende antiacoagulacion y ante ´posible absceso se decide mantener terapia antibiotica; ayer es evaluada por residente de turno pues manifiesta dolor en MII y adormecimiento se realiza control de TAC de abdomen y pelvis c/c con hematoma retroperitoneal derecho con componente muscular intramuscular y difusos en ambos músculos iliacos sin observar focos de extravasación activa de medio de contraste; se solicita evaluación por Cirugía (cumplida). Se realizó seguimiento a hematoma descrito previamente sin mayores cambios. Cirugía descartó abordaje. En relación a contexto infeccioso se cumplio con terapia ATB con Cloxacilina + Clindamicina, sin complicaciones. Descenso de parámetros inflamatorios con descenso de compromiso clínico sobre extremidad afectada. Se decidió prolongar terapia con VO con flucloxacilina. Durante estancia concurriendo con compromiso sobre muslo izquierdo asociado a dolor y limitación funcional, probablemente en contexto de compromiso de extremidad además de compromiso de raíces. Buena evolución clínica, capaz de deambular con limitación, por lo que se mediará derivación a domicilio con seguimiento de HODOM para KNT.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo

2. Regimen hiposódico, liviano
3. Omeprazol 20mg vo dia
4. Carvedilol 25mg vo c12h
5. Losartan 50mg vo dia
6. Furosemida 40mg vo dia
7. Pregabalina 150mg vo c12h
8. Carbamazepina 200mg vo c8h
9. Espironolactona 25mg vo dia
10. Tramadol 50mg vo c12h SOS
11. Paracetamol 1gr ev c8h
12. Flucloxacilina 500mg vo c6h (5/7)
13. B ipratropio 2 puff c6h
14. Brexotide 2 puff c12h
15. Control poli Cirugia <30 días
16. KNT 1 vez al día (HODOM)
17. Control SU SOS
18. Valoración y seguimiento APS

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAP c/c: presencia material hemático en el espacio pararenal posterior derecho, sin conformar una colección de pared definida. Diverticulosis colónicos sin signos de complicación.
TAC de cerebro: Focos de hipodensidad de la sustancia blanca de carácter microangiopático.
TAC de fémur izq : cambios degenerativos de la art femoropatelar a pred del comportamiento medial. En tercio medio de la cara anterior del muslo se evidencia una formación nodular de aspecto ganglionar en rango adenomegalico
Tac de Tórax (30/09/24) Pequeñas bandas atelectásicas bibasales. Dilatación del tronco de la arteria pulmonar, puede reflejar hipertensión pulmonar. Calcificaciones coronarias
TAC abdomen y pelvis (30/09/24) Hernia umbilical no complicada. Resto del estudio impresiona normal para la edad.
Tac de columna dorsal y Lumbar (30/09/24): Osteólisis cortical y trabecular en plataforma superior a derecha del cuerpo vertebral L5 con leve disminución de altura y leves cambios inflamatorios perivertebrales, sugerentes de una espondilitis-espondilodiscitis. Cambios degenerativos multisegmentarios de la columna dorsal y lumbar.
HC 1 / 2 (30/09/24) Streptococcus agalactiae (Strep. grupo B) – UC (-)
Ecocardiograma (02/10/2024): sin imágenes sugerentes de vegetaciones. Ventrículo izquierdo no dilatado de geometría normal y FEVI conservada 54%. Función diastólica normal. Insuficiencia mitral leve. Aurícula izquierda no dilatada. Cavidades derechas no dilatadas. VD con función sistólica normal. Sin signos sugerentes de HT pulmonar. Pericardio normal.

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO